

1. Datos del paciente

ID Paciente	P008
NHC	NHC-2020-005678
Nombre completo	Lucía Herrero Navarro
Sexo	Mujer
Fecha nacimiento	17/06/1978
Edad	47 años
DNI	44.321.876-M
Teléfono	667 543 210
Municipio	Burriana
Médico responsable	Dr. Javier Soler Pascual
Especialidad	Psiquiatría

2. Antecedentes personales

- Trastorno bipolar tipo I, episodios múltiples, actualmente en remisión parcial (diagnóstico 2005, CIE-10: F31.7)
- Tres hospitalizaciones por episodios maníacos (2005, 2012, 2020)
- Último episodio maníaco con síntomas psicóticos en marzo 2020 (ingreso 18 días)
- Episodios depresivos intercurrentes frecuentes (último episodio depresivo grave en 2023)
- Hipotiroidismo secundario a litio (2018)
- Alergia a sulfonamidas

Antecedentes familiares: Madre: trastorno bipolar tipo II. Abuela materna: episodios depresivos recurrentes, suicidio consumado a los 62 años. Padre: sin antecedentes psiquiátricos.

3. Historia clínica actual

Paciente de 47 años con trastorno bipolar tipo I diagnosticado a los 26 años tras un primer episodio maníaco con síntomas psicóticos (grandiosidad delirante, disminución de la necesidad de sueño a 2 horas/noche, verborrea, conductas de riesgo financiero con gastos descontrolados de más de 15.000 euros en una semana). Ha presentado tres episodios maníacos que requirieron hospitalización y múltiples episodios depresivos de gravedad variable. El último episodio maníaco (marzo 2020) cursó con ideación de grandeza, hiperactividad desorganizada y alucinaciones auditivas congruentes con el estado de ánimo. Tras estabilización se ajustó tratamiento a litio más quetiapina. En 2023 presentó episodio depresivo grave con características melancólicas (anhedonia absoluta, despertar precoz, pérdida de 8 kg en 6 semanas, ideación de muerte sin plan), que remitió tras añadir lamotrigina. Actualmente en remisión parcial con eutimia predominante pero con ciclación residual: presenta oscilaciones leves del estado de ánimo cada 3-4 semanas, de intensidad subclínica. Buena adherencia terapéutica. Trabaja como administrativa a media jornada. Convive con su pareja. Niega consumo de tóxicos. Sueño de 7 horas con ayuda farmacológica.

4. Exploración

Aspecto general	Consciente, orientada, colaboradora. Buen aspecto general e higiene. Contacto adecuado
Psicomotricidad	Normal. Sin agitación ni inhibición
Estado de ánimo	Eutímico. Afecto reactivo, modulado, congruente. Refiere 'días grises' aislados 2-3 veces al mes

Pensamiento	Curso y velocidad normales. Contenido sin ideación delirante. Sin ideación autolítica
Sensopercepción	Sin alteraciones actuales
Cognición	Preservada. Refiere quejas subjetivas de memoria que atribuye a la medicación
Conciencia de enfermedad	Buena. Identifica pródromos de episodios maníacos y depresivos
Sueño	7 horas con quetiapina. Sin insomnio actual
Peso / Talla / IMC	72 kg · 168 cm · 25,5 kg/m ²
Tensión arterial	124/78 mmHg
Frecuencia cardíaca	68 lpm, rítmica

5. Tratamiento actual

Fármaco	Posología
Litio 400 mg	1 comp. en desayuno y cena (litemia objetivo: 0,6-0,8 mEq/L)
Quetiapina 200 mg	1 comp. en cena (estabilizador coadyuvante + hipnótico)
Lamotrigina 200 mg	100 mg en desayuno y 100 mg en cena (prevención de recaídas depresivas)
Levotiroxina 50 mcg	1 comp. en ayunas (hipotiroidismo por litio)

6. Resultados de laboratorio

Parámetro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
Litemia	0,72 mEq/L	0,6–0,8	Normal	0,68 mEq/L
TSH	6,4 mU/L	0,4–4,0	Alto	5,1 mU/L
T4 libre	0,85 ng/dL	0,8–1,8	Normal	0,92 ng/dL
Creatinina	0,9 mg/dL	0,6–1,1	Normal	0,85 mg/dL
Filtrado glom.	82 mL/min	> 60	Normal	88 mL/min
Calcio	9,8 mg/dL	8,5–10,5	Normal	9,6 mg/dL
Hemograma	Normal	—	Normal	Normal
Glucosa	96 mg/dL	70–110	Normal	94 mg/dL

7. Plan de actuación

1. Mantener pauta actual: litio 800 mg/día + quetiapina 200 mg/noche + lamotrigina 200 mg/día
2. Valorar aumento de levotiroxina a 75 mcg si TSH sigue en ascenso en próximo control
3. Monitorización de litemia y función renal cada 3 meses
4. Psicoeducación: reforzar registro diario de estado de ánimo y sueño para detección precoz de ciclación
5. Psicoterapia de apoyo quincenal (IPSRT — terapia de ritmos sociales)
6. Control analítico en 3 meses: litemia, TSH, creatinina, calcio, hemograma
7. Revisión en consulta en 8 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.